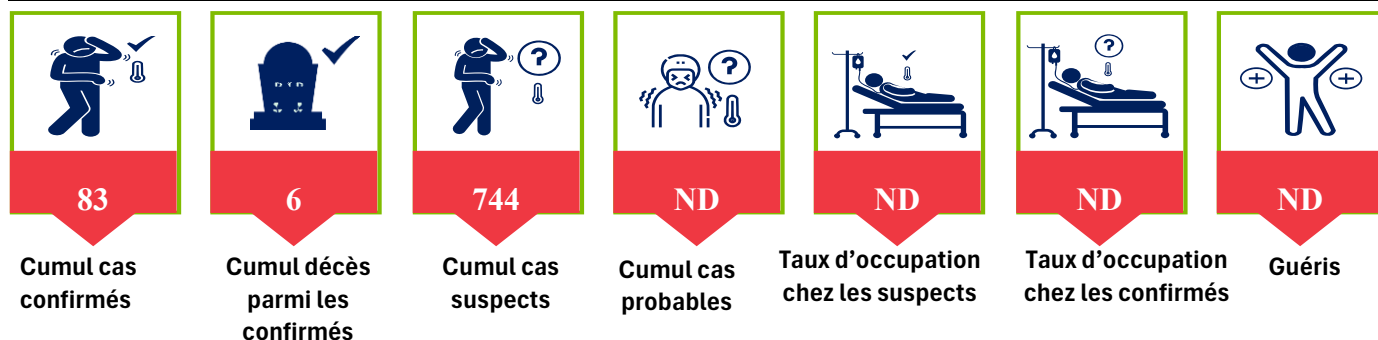


Centre des opérations d'urgences de sante publique
« COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la 17ème épidémie de la Maladie à Virus EBOLA (MVE) /RDC
SitRep MVE N° 007/MVB_17/2026

Provinces touchées	ITURI, NORD-KIVU
Zones de Santé touchées	ITURI : Mongbwalu, Rwampara, Bunia, Nyankunde, Bambu et Kilo NORD KIVU : Goma, Katwa et Butembo SUD KIVU : Miti-Murhesa
Date de rapportage	21 mai 2026
Date de publication	22 mai 2026



Répartition des cas et décès confirmés par zone de santé dans les provinces touchées

Provinces touchées	Zones de santé avec cas confirmés	Nouveaux cas confirmés	Nouveaux décès parmi confirmés	Nouveaux cas probables	Nouveaux cas suspects	Nouveaux contacts listés	Guéris du jour
Ituri	Bunia	6	1	ND	41	87	0
	Rwampara	7	1	ND	14	0	0
	Mungbwalu	1	0	ND	5	0	0
	Bambu	0	0	ND	0	48	0
	Nyankunde	2	0	ND	9	207	0
	Nizi	1	0	ND	1	ND	0
	Kilo	1	0	ND	1	ND	0
Sous total		18	2	0	70	342	0
Nord-Kivu	Goma	0	0	ND	ND	ND	0
	Butembo	0	0	ND	ND	ND	0
	Katwa	0	0	ND	ND	ND	0
Sud Kivu	Miti Murhesa	1	0	ND	ND	ND	0
Sous total		1	0	0	0	0	0
Total		19	0	0	70	342	0



Présentation du plan de préparation et réponse de la 17ème épidémie de la Maladie à Virus Ebola ce 21 mai 2026 au COUSP, autour du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique.



Visite du DG de Africa CDC à Bunia, province de l'Ituri (Réunion autour du gouverneur avec les autres partenaires)

I. CONTEXTE

La province de l'Ituri est située au Nord-Est de la République Démocratique du Congo et partage une longue frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Depuis plus de deux décennies, elle est confrontée à une crise humanitaire chronique liées aux conflits armés et des déplacement récurrents des populations. Elle compte une population estimée à plus de 8 millions d'habitants parmi lesquels plus d'un million de déplacés internes.

En septembre 2018, cette province était touchée par une épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévissait dans la province voisine du Nord-Kivu.

La zone de santé de Mongbwalu est l'une des 36 zones de santé de la province de l'Ituri. Considérée comme point de départ de l'épidémie elle est située dans le territoire de Djugu où opèrent plusieurs groupes armés. Elle est située à 70 km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, avec des mouvements fréquents des populations vers l'Ouganda. Cette localité a particularité d'avoir plusieurs chantiers qui attirent les populations venant des autres territoires de la province et des provinces voisines.

II. HISTORIQUE DE L'EPIDEMIE

En date du 05 mai 2026, les réseaux sociaux déclarent une flambée de décès de cause inconnue avec près de 50 décès déjà enregistrés dans la zone de santé de Mongbwalu. Après la confirmation de cette alerte, le Médecin chef de la zone de santé de Mongbwalu partage le rapport de l'investigation préliminaire le 09 mai 2026. Le 11 mai 2026, les autorités sanitaires provinciales organisent une réunion d'urgence et décident de déployer des équipes d'intervention rapide à Mongbwalu et à Rwampara qui avait rapporté des décès suspects de fièvre hémorragique virale chez des malades internés au Centre médical Evangélique de Rwampara, provenant de Mongbwalu.

Les investigations menées le 12 mai 2026, simultanément dans les zones de santé de Mongbwalu et de Rwampara par les Equipes d'Intervention Rapide de la Division provinciale de la santé (DPS) de l'Ituri ont permis de relever que la plupart des patients ou décès suspects avaient la fièvre, les céphalées, les vomissements, une asthénie physique intense. Les décès

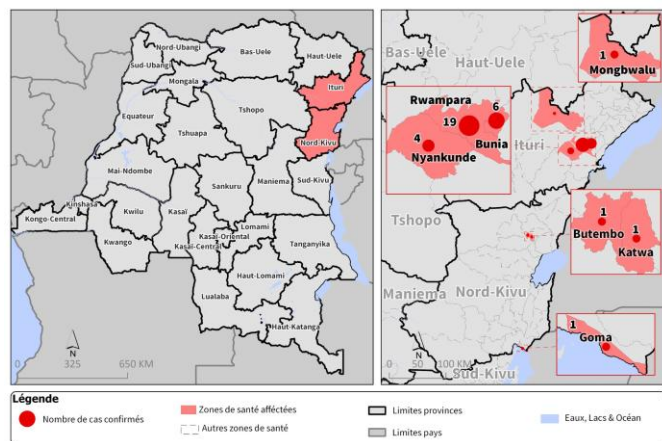
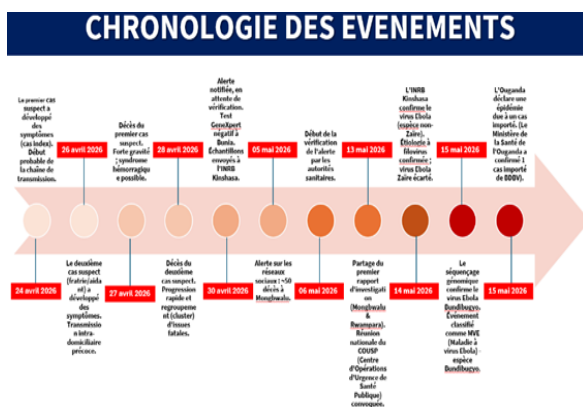
survenaient 2 à 3 jours après le début de la maladie dans un tableau d'hématémèse, épistaxis ou de vomissement noirâtre. Au cours des investigations dans la zone de santé de Rwampara, 20 échantillons sur les cas ou décès suspects ont été effectués. La majorité des personnes prélevées provenaient de la zone de santé de Mongbwalu. Les tests préliminaires effectués au Laboratoire de Bunia étaient tous négatifs pour Ebola zaire, dengue, Rotavirus, Cholera, Paludisme, Yersinia pestis, mpox et COVID-19. Ces échantillons ont été envoyés à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) de Kinshasa pour des examens additionnels.

En date du 14 mai 2026, **13 cas de ces 20 échantillons ont été testés et 8 se sont révélés positifs** à la maladie à virus Ebola non-Zaire à l'INRB Kinshasa. Le 15 mai 2026, le séquençage des échantillons positifs a permis d'identifier la souche BUNDIBUGYO, *ce qui a permis au ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale (MSHPS) de déclarer officiellement la 17-ème épidémie de la maladie à virus Ebola.*

la maladie à virus Ebola (souche Bundibugyo), marquant ainsi la 17e épidémie de l'histoire du pays

En date du 17 Mai 2026, en concertation avec les états membres, le Directeur général de l'OMS estime que l'événement qui se passe en RDC et en Ouganda répondent aux critères de la définition énoncés à l'article 1 du RSI, et a déclaré que cela constitue une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale tout en précisant que le risque au niveau mondial est faible mais élevé au niveau régional.

Le 18 mai 2026, le Directeur général du CDC Afrique a officiellement déclaré une urgence de santé publique de sécurité continentale (USPSC) en vertu de l'article 3 de ses statuts. Cette déclaration faisait suite à une réunion d'urgence du groupe consultatif du CDC Afrique, qui a estimé que l'aggravation de l'épidémie constituait un risque aigu pour la sécurité sanitaire continentale. En conséquence, l'équipe continentale de soutien à la gestion des incidents a été activée afin d'apporter son soutien aux États membres touchés et à ceux exposés aux risques, en matière de réponse et de préparation.



Les frontières et les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion que ce soit de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant le statut politique de tout pays, territoire, ville ou région sous son autorité, ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites. [Source des données: MSPH RDC.] [Réalisation: Equipe INRB Kinshasa.] Copyright: OMS 2026

III. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- 19 nouveaux cas confirmés dont 18 en Ituri (Rwampara : 7, Bunia : 6, Nyakunde : 2, Nizi : 1, Mongbwalu: 1 et Kilo Mission : 1) et 1 au Sud-Kivu (Miti Murhesa)
- Le cumul des cas confirmés est de 83 cas dont 78 dans la DPS Ituri, 4 dans le Nord-Kivu et 1 dans le Sud Kivu.
- Une nouvelle province touchée (Sud-Kivu) à travers la ZS de Miti-Murhesa et une nouvelle ZS touchée (Kilo Mission) dans la province de l'Ituri.
- Globalement, 10 ZS sont touchées et réparties dans 3 provinces dont 6 ZS (Ituri), 3 ZS (Nord-Kivu) et 1 ZS (Sud-Kivu).
- Le taux de positivité des tests est de 45,9% (17/37 échantillons analysés).
- La proportion de contacts suivis est de 21,3% pour la journée du 21 mai 2026.
- Réunion de la Coordination avec le pilier Surveillance (recadrage sur l'organisation du pilier surveillance)

IV. ACTIONS DE REPONSE

COORDINATION

- Tenue d'une réunion de coordination présidée par l'Incident Manager Adjoint, Chef de la Division Provinciale de la Santé du Nord-Kivu (Beni) et Ituri (Bunia).
- Tenue de la réunion de mobilisation des partenaires sur l'alignement au plan de réponse.
- Élaboration du plan d'action provincial de l'incident de la Maladie à Virus Ebola dans la DPS Ituri et Nord-Kivu.

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- Élaboration de draft de Terme de référence pour le déploiement des équipes provinciales multidisciplinaires dans la ZS de Mongbwalu.
- Elaboration du draft de TDR de formation des acteurs (ECZS, IT&ITA, les leads des agents communautaires et les gestionnaires de données) de cinq ZS actives
- Dotation de thermo flash dans les ZS de Bunia (12) et Rwampara (11) pour le suivi de contact.

Tableau I. Récapitulatif de la situation des alertes à la date du 21 mai 2026

Suivi des alertes	Report des alertes (20/05)	Nouvel les alertes (21/05)	Total des alertes du jour (21/05)	Alertes vivants	Alertes décédés	Alertes investiguées	Alertes non investiguées	Alertes validées	Alertes invalidées	Cas suspects prélevés	Cas suspects non prélevés	Cas suspects isolés	Cas suspects non isolés
Bunia	4	39	43	40	3	41	2	41	0	17	24	41	0
Rwampara	6	20	26	19	7	14	12	14	0	12	2	12	0
Nyankunde	0	10	10	9	1	9	0	10	0	10	0	9	0
Mongbwalu	0	7	7	3	4	5	2	5	0	4	1	1	0
Bambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nizi	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Lita	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Fataki	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Logo	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Aungba	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Rethy	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Komanda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nyarambe	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Aru	0	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Drodro	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Mambassa	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Mangala	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Lolwa	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Tableau III. Récapitulatif de l'identification et suivi de contacts à la date du 21 mai 2026

Zones de santé	Suivi journalier						Taux de suivi	Total non vus	Raison de non vus						Reste à suivre le jour suivant
	Report du 19/05/2026	Nouveaux contacts le 20/05/2026	Contact à suivre ce jour	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects			Simple Absence	Perdus de vue (≥72 heures)	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	
Bunia	203	87	290	87	0	0	30%	203	0	0	0	0	0	203	290
Rwampara	621	0	621	0	0	0	0%	621	0	0	0	0	0	621	621
Nyankunde	133	207	340	207	0	0	61%	133	0	0	0	0	0	133	340
Mongbwalu	176	0	176	0	0	0	0%	176	0	0	0	0	0	176	176
Bambu	128	48	176	48	0	1	27%	128	0	0	0	0	0	128	176
Total	1261	342	1603	342	0	1	21%	1261	0	0	0	0	0	1261	1603

Tableau IV. Répartition des cas, décès suspects et confirmés de maladie à virus Ebola dans les zones de santé de la DPS Ituri et Nord-Kivu au 21 mai 2026

Provinces	Zones de santé	Nbre de cas suspects	Nbre de décès suspects	Nbre de cas Confirmés	Nbre de contacts
Ituri	Mongbwalu	322	84	14	176
	Rwampara	193	51	31	621
	Bunia	166	34	15	290
	Nyankunde	38	6	11	340
	BAMBU	2	0	1	176
	Nizi	3	1	1	ND
	Kilo Mission	1	0	1	ND
	Echantillons sans fiche	0	0	4	0
Nord-Kivu	Goma	0	0	1	ND
	Katwa	13	0	2	ND
	Butembo	7	0	1	ND
Sud-Kivu	Miti Murhesa	1	0	1	ND
Total		745	176	83	1603

* Ces données sont susceptibles de changer après harmonisation des données à différents niveaux de la pyramide sanitaire avec le système de gestion des incidents.

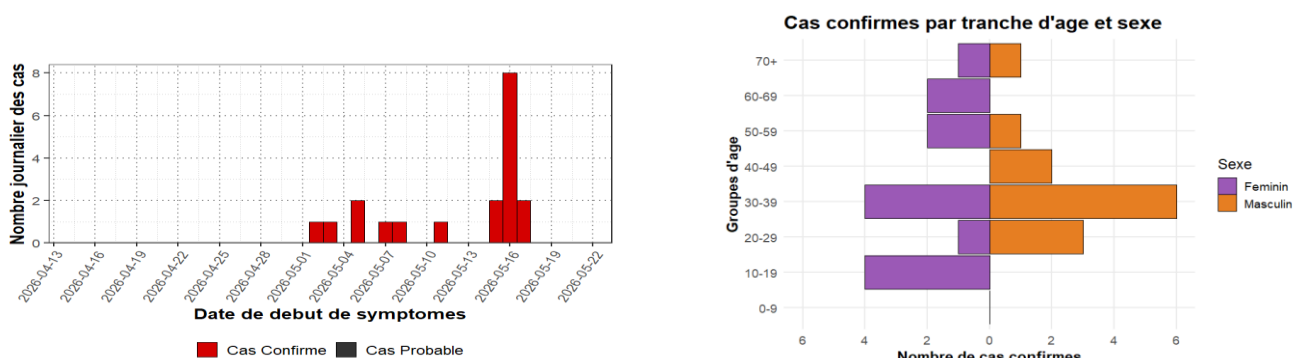


Figure 1. Evolution de cas confirmé dans la DPS Ituri par date de début de symptômes (source : DHIS2 Tracker partiel)

Surveillance aux Points d'entrées et Points de contrôle (PoE/PoC)

- Réunion journalière de coordination des activités.
- Encodage des données des PoE/PoC(base des données).
- Reportage des données journalières.
- Supervision et suivi des activités.

Tableau V. Synthèse de données (PoE/PoC) du 21/05/2026

Zone de santé	PoE/PoC	Tot v passées	Tot v screenés	Total lavage de mains	Tot v sensibilisés	Tot alertes	Tot refus Lavage mains	Tot refus screening
NIZI	PONT NIZI	0	0	0	0	0	0	0
BUNIA	AEROPORT	189	189	189	189	0	0	0
	MUDZIBALA	355	355	355	355	0	0	0
	PONT SIMBILIABO	0	0	0	0	0	0	0
RWAMPARA	PONT SHARI	0 102	0 102	0 102	0 102	0 0	0 0	0 0
	DELE	0	0	0	0	0	0	0
	CHAI	105	105	105	0	0	0	0
TCHOMIA	TCHOMIA	0	0	0	0	0	0	0
	NYAMUSASI	186	186	186	186	0	0	0
	KASENYI	0	0	0	0	0	0	0
	MANDJE	0	0	0	0	0	0	0
NYAKUNDE	MARABO	0	0	0	0	0	0	0
	ENTREE NYAK.	0	0	0	0	0	0	0
	SOTA	0	0	0	0	0	0	0
	PONT TALOLO	0	0	0	0	0	0	0
MUNGWALU	POIPO	0	0	0	0	0	0	0
	MAHIDEDE	0	0	0	0	0	0	0
	PONT PLITO	0	0	0	0	0	0	0
	PONT KIRIKOU	0	0	0	0	0	0	0

LABORATOIRE

Total	
Cumul échantillons reçus	290
Ré prélèvements (contrôle)	3
Cumul échantillons analysés	171
Cumul positifs	77

REPARTITION DES ECHANTILLONS TESTES AU LABO BUNIA PAR NATURE

Date	Provenance /ZS	Nombre échantillons testés	Natures d'échant		Reprévelem ent	Positifs		Négatifs		Indéterminés	
			Sang	Swab		Sang	Swab	Sang	Swab	Sang	Swab
21/05/2026	Bunia	11	10	1	0	5	1	5	0	0	0
	Rwampara	8	7	1	0	6	1	1	0	0	0
	Nyakunde	15	15	0	0	2	0	13	0	0	0
	Mongbwalu	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Bambu-mine	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Nizi	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL		37	35	2	0	15	2	20	0	0	0

REPARTITION DES ECHANTILLONS REPRELEVES

Date	Provenance/ZS	Reprélevé	Diagnostic				Suivi	
			Résultats P1		Résultats P2		Résultats P3 à P5	
			Positifs	Négatifs	Positifs	Négatifs	Positifs	Négatifs
21/05/2026	Bunia	0	0	0	0	0	0	0
	Rwampara	0	0	0	0	0	0	0
	Nyakunde	0	0	0	0	0	0	0
	Mongbwalu	0	0	0	0	0	0	0
	Bambu-mine	0	0	0	0	0	0	0
	Nizi	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

RESULTATS DU JOUR : 21/05/2026

Date	Provenance /ZS	Nombre échantillons testés	Natures d'échant		Reprévelem ent	Positifs		Négatifs		Indéterminés	
			Sang	Swab		Sang	Swab	Sang	Swab	Sang	Swab
21/05/2026	Bunia	11	10	1	0	5	1	5	0	0	0
	Rwampara	8	7	1	0	6	1	1	0	0	0
	Nyakunde	15	15	0	0	2	0	13	0	0	0
	Mongbwalu	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Bambu-mine	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Nizi	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL		37	35	2	0	15	2	20	0	0	0

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (CREC)

- Plaidoyer auprès de son Excellence l'Evêque du Diocèse de Bunia en mission, représenté par le Vicaire Général pour obtenir son engagement en appui aux a
- plaidoyers auprès des bourgmestres des communes de SHARI, NYAKASANZA et MBUNYA pour obtenir leur engagement en appui aux activités de la communication à la riposte MVE
- Sensibilisation de 38 éleveurs et marchands de gros bétails à l'abattoir industriel de Bunia sur les mesures préventives à la MVE dont 16 femmes et 22 hommes
- 9 responsables de l'Eglise du Christ au Congo sensibilisées sur les mesures préventives à la MVE et acceptent que l'équipe CREC viennent passer les messages lors de culte dominicale.
- 2 responsables de la communauté Islamique sensibilisées et acceptent la CREC de passer dans les 5 mosquées pour ce vendredi 22 mai 2026 (Ville, Cité, YAMBI, PRISON et KANYASI).
- 1 responsable de la communauté Kimbanguiste sensibilisée et accepte que la CREC passe les messages lors de leur culte dominicale;
- L'Eglise CHRISCO invite l'équipe CREC de passer les messages lors de leur culte dominicale;
- ZS RWAMPARA, 25 personnes sensibilisées sur les mesures préventives, dont 15 femmes et 10 hommes dans l'AS SHARI lors de la recherche et suivi des cas évadés à l'HGR Bunia

PREVENTION ET CONTROLE DE L'INFECTION

ZS Bunia

- 2 EDS réalisés et 1 en cours.
- Briefing de 5 prestataires de soins de salle d'urgence de l'HGR-Bunia sur les mesures préventives
- Dotation des EPI et équipements de décontamination pour la séance pratique des équipes de ZS Bunia.

- Décontamination du bâtiment d'isolement de l'HGR-Bunia.
- Dotation des quelques intrants PCI par le partenaire ALIMA

ZS Rwampara

- Briefing des 4 personnels de la Morgue Balidja sur le port des EPI avant la manipulation de tout corps ;
- Poursuite de briefing des 63 prestataires de soins (Hygiénistes, infirmiers, Médecins et Sage-femmes de CME Nyakunde) sur la gestion des déchets biomédicaux.
- 3 EDS réalisés et 1 en cours.
- Décontamination de la salle d'isolement à l'HGR/Rwampara.
- Briefing de 10 techniciens de surface et 15 superviseurs PCI sur le port et retrait des EPI.

ZS Mongbwalu

- Supervision formative dans 4 structures de santé dont : CS Uponyaji, CS Rwampara, Poste de santé Amani et CS Tchungu (sans faire l'évaluation);

DPS Nord Kivu

- Décontamination de l'Hôpital Matanda où séjourne le cas confirmé de la ZS de Katwa;
- Évaluation score card PCI de l'Hôpital Matanda: 70,6%;
- Réalisation du mapping du cas;
- État de lieu du CTE pour le dégagement des besoins en intrants PCI (Epi, approvisionnement en eau, gestion des déchets, circuit du malade).

PREVENTION ET CONTROLE DE L'INFECTION

- Élaboration de l'état de besoin en logistique des ZS Goma, Katwa, Beni, Karisimbi, Mutwanga, Vuhovi, Kalunguta, Kamango, Mabalako, Oicha, Museniene, Kayina, Alimbongo, Butembo ;
- Acquisition des kits Starling pour la connexion internet en provenance de l'UNICEF ;
- Réception de 5 véhicules dotation de l'OMS ;
- Réception de 200 litres de Gasoil (Appui de MEMISA-Belgique).

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE

- Briefing des prestataires des prestataires à l'HGR Bunia et Rwampara sur le port d'EPI ;
- Evaluation cliniques des patients ;
- Acheminement de 5 matelas, 5 lits et autres matériels au CME
- Montage de deux tentes d'isolement en cours à l'HGR Bunia ;
- Aménagement d'une salle à l'HGR Bunia en cours.
- Evaluation de l'état nutritionnel des malades en isolement au CME.
- 14 annonces des résultats ;
- Sensibilisation de 97 aidants familiaux, 9 hygiénistes, 11 ouvriers, 92 enseignants du CSJM et 25 taximans ;
- Entretien de famille avec 4 familles de décédés ;

**Tableau VI. Mouvement des malades dans les établissements de soins en date du
21 mai 2026**

Indicateurs		HGR Bunia	RWAMPARA			Mongbwalu	Nyankunde	Total Général
Report		36	21	15	35	27	16	129
Nouvelles Admissions	PPL	1	0	0	0	0	7	8
	Autres	13	2	4	6	9	0	28
	Total	14	2	4	6	9	7	36
Total en Isolement		50	23	19	46	36	23	165
Sorties	Guéris	0	0	0	0	0	0	0
	Décédés	8	4	4	10	5	0	23
	Cumul de décès	46	10	15	25	44	1	116
	Non Cas	0	0	0	0	0	0	0
	Evadés	9	0	0	0	1	0	10
	Transférés à HGR	0	0	0	0	0	0	0
Malades en isolement	Suspects	48	21	17	38	35	17	138
	Dont prélevés	26	ND	1	1	0	7	34
	Dont sévères/critiques	12	1	1	2	0	0	14
	Dont Femmes enceintes	0	0	0	0	1	0	1
	Dont Femmes allaitantes	2	0	0	0	1	0	3
	Dont Suspect Enfant < 5 ans	6	0	0	0	1	0	7
	5 à 14 ans	3	0	0	0	2	0	5
	Total cas confirmés	4	2	2	4	1	6	15
	Dont Nouveaux cas Confirmés	2	0	0	0	1	1	4
	Dont AC Confirmés	0	2	1	5	0	4	9
	Dont sévères/critiques	2	0	1	2	0	0	4
	Dont avec comorbidités	1	0	0	0	0	0	1
	Dont Femmes enceintes	0	0	0	0	0	0	0
	Dont Femmes allaitantes	0	0	0	0	0	0	0
	Dont Suspect Enfant < 5 ans	0	0	0	0	0	0	0
	5 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	0

SECURITE

- La situation sécurité dans la ville de Bunia (ZS de Bunia et Rwampara) est relativement calme
- Briefing sécuritaire aux équipes déployées.

V. DEFIS

- Absence des CT et CTE normés
- Manques des matériels PCI (EPI, DLM, chlore) au Nord Kivu
- Faible remontée des alertes par les zones ;
- Insuffisance des ressources financières pour appuyer tous les piliers de la riposte ;
- Difficulté d'acheminements des échantillons vers les laboratoires de Goma et Kinshasa.
- Propagation des rumeurs et prolifération des recettes de traitement traditionnel.
- Absence des supports et outils de communication.
- Faible capacité de diagnostic
- Quantité insuffisante en intrants et réactifs

VI. Recommandation

- Rendre opérationnel les CT et CTE de Beni, Butembo et Goma (réhabilitation et révision du circuit)
- Renforcer la surveillance en vue de la remontée des alertes et la recherche des contacts jamais vus et perdus de vue ;
- Mobiliser les ressources pour soutenir les différents piliers de la riposte ;
- Formation des prestataires sur la surveillance en MVE et en SBC dans les ZS touchées et à haut risque ;
- Formation des Agents communautaires sur la surveillance en MVE et en SBC dans les ZS touchées et à haut risque.



Réception de 14 tonnes de matériels logistiques, EPI et kits PEC en provenance de Kinshasa (OMS) et 19 tonnes des intrants et Kits PCI (UNICEF)



CAMON 305

016mm 8/1.0 1/3443 150550

Incendie du centre d'isolement Rwampara



Installation d'un point de lavage des mains au PoC

**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Tel. : +243 816 040 145

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

E-mail : Christian.ngandu@insp.cd

Tél. : +243998091915

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr Anne Marie ANCIA

E-mail : anciaa @who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr FOTSING Richard

E-mail: fotsingri@who.int

Pour l'Africa CDC

Justus Nsio Mbeta

E-mail : JustusNs@africacdc.org